



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Otorrino

Acude a la urgencia un paciente hepatópata con plaquetopenia por inflamación cervical y sangrado oral tras exodoncia de 4 piezas dentarias. A la exploración presenta un cuello duro y empastado con equimosis cervical y un abombamiento del suelo de boca que impide al paciente la protrusión de la lengua. Señale la opción CORRECTA en relación a esta situación:

1. Debemos derivar al paciente al odontólogo.
2. El paciente tiene un hematoma de suelo de boca que puede suponer un peligro para la vía aérea.
3. El paciente tiene una angina de Ludwig por lo que habrá que tratarle con un macrólido y corticoides.
4. La exodoncia no tiene relación con la situación actual.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Opción 2 correcta: La exodoncia en un paciente con riesgo hemorrágico puede causar una hemorragia de suelo de boca que comprima la vía aérea. Todavía no es una angina de Ludwig ya que es un acúmulo de sangre y no de pus, pero se comporta de la misma manera.

-----o-----

Señale lo cierto respecto al cáncer de laringe:

1. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma
2. Es más frecuente en mujeres
3. Su tratamiento se basa en la radioterapia y quimioterapia
4. Se trata del cáncer más frecuente de cabeza y cuello

Resp. Correcta: 4

Comentario: El cáncer de laringe es el más frecuente de cabeza y cuello (respuesta 4 correcta), el tipo histológico más frecuente es el epidermoide (respuesta 1 falsa), es más frecuentes en varones de edad media (respuesta 2 falsa) y su tratamiento se basa en la cirugía asociada a radioterapia en estadios avanzados (respuesta 3 falsa)

-----o-----

Con respecto a la fractura longitudinal del peñasco, es FALSO que:

1. La hipoacusia es de transmisión.
2. Puede existir otolicuorrea.
3. La parálisis facial es más frecuente que en la fractura transversa.
4. Puede verse un "escalón" en el *annulus* timpánico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La fractura longitudinal del peñasco presenta la línea de fractura paralela al eje aéreo y es típica la presencia de hematoma retroauricular, escalón en el *annulus* timpánico con otorragia por rotura de la membrana timpánica e hipoacusia de transmisión por luxación de la cadena de huesecillos. Pueden existir otolicuorrea y parálisis facial periférica como en la fractura transversa pero es menos frecuente que en ella (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Paciente con neurofibromatosis tipo II con hipoacusia neurosensorial, acúfenos unilaterales y con parálisis facial ipsilateral. A la exploración otoscópica se detecta anestesia de la pared posterior del conducto auditivo externo. ¿Cómo se denomina este último signo?

1. Signo de Weber.
2. Signo de Ramsay-Hunt.
3. Signo de Rinne.
4. Signo de Hitselberger.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El signo de Hitselberger es un signo que se caracteriza por una alteración de la sensibilidad en la pared posterior del CAE y se debe a la lesión de las fibras sensitivas del nervio facial, que recogen la sensibilidad del área de Ramsay-Hunt (respuesta 4 correcta). En los pacientes con neurofibromatosis tipo II (enfermedad autosómica dominante localizada en el cromosoma 22) son típicos los neurinomas en los pares craneales, sobre todo en el VIII par, y de forma bilateral.

-----O-----

Señale la cierta con respecto al signo de Schwartz:

1. Es patognomónica del neurinoma del VIII par.
2. Es la hiperemia del promontorio en la otosclerosis, vista a través del tímpano.
3. Se ve en todos los casos de otosclerosis.
4. Es la provocación de un nistagmo ante los ruidos fuertes.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: El signo de Schwartz es una mancha rojiza por hiperemia que aparece en el promontorio de algunas otosclerosis. Indica un foco otosclerótico activo y suele acompañarse a otosclerosis con componente coclear.

Además de no estar presente en todas las otosclerosis es necesario que la membrana timpánica presente algo de transparencia para poder observarla.

-----O-----

Señale la afirmación falsa sobre el carcinoma laríngeo:

1. Los carcinomas glóticos suelen debutar con disfonía y son los de mejor pronóstico.
2. Los carcinomas subglóticos suelen debutar con sensación de cuerpo extraño
3. Los carcinomas supraglóticos presentan adenopatías mas frecuentemente y por ello son de peor pronóstico
4. Los carcinomas subglóticos tiene frecuentemente afectación ganglionar cervical

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Debemos recordar que según la localización de los carcinomas de laringe se presentan mas frecuentemente ciertos síntomas.

Glottis: Disfonia

Supraglottis: sensación de cuerpo extraño, parestésias, odinofagia con otalgia refleja, disfagia.

Subglóticos: Disnea o estridor. Opción 2 correcta.

También que los glóticos son de mejor pronóstico y los supraglóticos los de peor pronóstico a nivel de la laringe.

-----O-----

Paciente mujer de 80 años de edad que consulta por parálisis facial periférica derecha de 24 horas de evolución. Refiere que lleva con dolor en pabellón y región periauricular derecha desde hace 3 días y presenta costras en dicho pabellón y conducto auditivo externo. Como antecedentes: tuvo en la infancia rubeola, varicela y sarampión. ¿Cuál será nuestro diagnóstico?

1. Síndrome de Melkersson-Rosenthal.
2. Síndrome de Heerfordt.
3. Síndrome de Landry-Guillain-Barré.
4. Síndrome de Ramsay-Hunt.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: síndrome de Ramsay-Hunt presenta una parálisis facial con costras dolorosas en pabellón auricular y conducto auditivo externo (resultado de la desecación de las vesículas ocasionadas por el virus del herpes zoster, que suelen ser efímeras y a veces difíciles de ver).

El antecedente de haber padecido varicela (herpes varicela-zoster) corrobora este cuadro clínico.

El síndrome de Melkersson-Rosenthal se caracteriza por una parálisis facial y afectación de cara y labio superior, además de surcos en la lengua. Se inicia en la infancia o adolescencia.

El síndrome de Heerfordt consiste en una uveoparotiditis con parálisis facial y fiebre.

El síndrome de Landry Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante que puede debutar afectando al nervio facial.

-----O-----

Cuál de las siguientes NO forma parte del protocolo HINTS:

1. Maniobra oculocefálica
2. Nistagmo
3. Índice de Barany
4. Test Skew

Resp. Correcta: 3

Comentario: Opción 3 correcta: El protocolo HINTS, como bien indican sus siglas, viene determinado por la prueba de impulso cefálico (Head Impulse Test), el nistagmo y el Test de Skew.

La etiología MÁS frecuente de hipoacusia en la infancia es:

1. La otosclerosis.
2. La meningitis.
3. La otitis media serosa.
4. El traumatismo acústico por incubadora.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La otitis seromucosa afecta al 10% de los niños entre 2 y 6 años, siendo la causa más frecuente de hipoacusia a esta edad; es una hipoacusia adquirida (opción 3 correcta). Se debe a la disfunción tubárica en la infancia (trompa de Eustaquio más horizontal, corta y flácida que en los adultos) y a la hipertrofia adenoidea, que impide la correcta ventilación del oído medio. También influye la adquisición de cuadros catarrales habituales en guarderías. La otoscopia y el timpanograma nos dan el diagnóstico, con tímpano con ocupación mucosa, cierta hiperemia y abombamiento, pero sin fiebre. La timpanometría es plana y la hipoacusia de tipo transmisivo. Tiene tratamiento, por lo que hay que diagnosticarla lo antes posible, para que la hipoacusia no interfiera en el desarrollo intelectual del infante, con lavados nasales y corticoterapia tópica. Si no hay mejoría, hay que valorar adenoidectomía y/o drenajes transtimpánicos. Recuerda que la causa más frecuente de HIPOACUSIA INFANTIL CONGÉNITA es la genética.

Un paciente se va a operar de un adenoma pleomorfo. ¿Cuál es la mejor manera de EVITAR un síndrome de Frey en el postoperatorio?

1. Conservar el SMAS.
2. Inyecciones de toxina botulínica.
3. Realizar una parotidectomía conservadora.
4. No es posible evitar un síndrome de Frey en tumores de este tipo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: El síndrome de Frey se previene conservando el SMAS (sistema musculoaponeurótico superficial) en la cirugía de parótida (de tumores benignos).

Las inyecciones de toxina botulínica son el tratamiento cuando el paciente ya padece un síndrome de Frey no para evitarlo.

De los cuatro casos clínicos que se exponen a continuación señale el que no encaje con el diagnóstico de otitis media aguda:

1. Paciente de 3 años de edad, irritable y pirético, con otalgia derecha tras un cuadro catarral de vías altas.
2. Paciente de 6 meses de edad con irritabilidad y fiebre de foco desconocido que muestra un eritema de la membrana timpánica y que mejora con la toma de amoxicilina oral.
3. Paciente de 4 años de edad con otalgia izquierda de 1 día de evolución que mejora tras el inicio de otorrea.
4. Paciente de 3 años de edad con sospecha de hipoacusia por parte de sus familiares y que muestra una membrana timpánica ambarina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La otitis media aguda se caracteriza por la presencia de fiebre, irritabilidad y otalgia.

El diagnóstico se basa en la clínica y la exploración física (membrana timpánica eritematosa y abombada). Con respecto a la clínica, la otalgia pulsátil inicial puede dar paso a una fase de mejoría sintomática tras la descarga purulenta.

El tratamiento habitual es con amoxicilina oral ajustada al peso.

La otoscopia con membrana sonrosada o ambarina es típica de la otitis media con efusión. En la otitis media con efusión no suele haber dolor ni síntomas infecciosos, por lo que marcamos la opción 4 correcta.

-----o-----

Paciente que presenta una tumoración parotídea de características malignas que en el informe anatomopatológico tras su extirpación describen como carcinoma mucoepidermoide. En el postoperatorio el paciente presenta como secuela una parálisis facial. Indique la afirmación MENOS acertada:

1. El carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente de la parótida.
2. El test de Schirmer demostrará una secreción lagrimal basal dentro de los rangos normales.
3. Puede estar afectada solo una región facial de la hemicara afecta (si se ha lesionado solo una rama del nervio facial). Si la lesión afecta a todo el tronco principal del nervio facial, la parálisis será de la hemicara completa.
4. Seguramente aparezca una alteración en la sensibilidad gustativa de la lengua.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta típica sobre parálisis facial periférica en la que hay que localizar topográficamente la lesión y, a partir de ahí, pensar en qué estructuras y cuáles no estarán afectadas. En este caso la lesión del facial se produce a nivel parotídeo, es decir, muy periférico, ya fuera del cráneo. El test de Schirmer evalúa la funcionalidad del nervio petroso superficial mayor, correspondiente a la primera porción del facial, la cual, al ser proximal a la lesión del facial estará conservada. La lesión a nivel parotídeo es distal a la tercera porción de la que depende la sensibilidad de la lengua y, por tanto, esta estará conservada (marcamos la opción de respuesta). Una lesión del facial a ese nivel producirá o una parálisis de la rama afecta o una parálisis completa de la hemicara en caso de lesionar el facial a la salida del agujero estilomastoideo. Recuerda que ante un déficit en el cierre ocular habrá que estar atento ante una posible aparición de queratitis por exposición. Además el carcinoma mucoepidermoide es el tumor maligno más frecuente de la parótida.

Respecto al carcinoma epidermoide de laringe señale cuál considera el factor pronóstico más importante

1. Afectación ganglionar (N)
2. Tamaño del tumor (T)
3. Edad del paciente
4. Relación con el Virus del Papiloma Humano

Resp. Correcta: 1

Comentario: Opción 1 correcta: El factor pronóstico más importante en el cáncer de laringe es la afectación ganglionar (N)

Respecto a los traumatismos alveolodentarios es falso qué:

1. En caso de avulsión traumática de pieza dental, es recomendable su reimplante precoz, idealmente en los primeros 30 minutos, y fijación mediante férula. Durante el transporte puede conservarse el suero/saliva o leche.
2. Las fracturas dentales pueden tratarse, mediante endodoncia.
3. La hemorragia tras avulsión suele ser autolimitada o cede tras compresión., salvo coagulopatía de base.
4. Las luxaciones de piezas dentales no requieren fijación ni férula

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Ante una avulsión traumática dental es imprescindible actuar con rapidez. La remplantación precoz puede salvar el diente.

La endodoncia es un método eficaz para el tratamiento de fracturas dentales así como para tratamiento diferido tras reimplante dental

La luxación dental requiere de ferulización temporal para asegurar su reimplante correcto por lo que marcamos la opción 4 correcta.

¿Qué lesión de las siguientes tiene mayor potencial de transformación maligna?

1. Leucoplasia
2. Eritroplasia
3. Lique plano
4. Papiloma oral

Resp. Correcta: 2

Comentario: En general toda lesión persistente de cavidad oral requiere de biopsia. La eritroplasia, aunque no frecuente, es la lesión con mayor potencial de transformación cancerígena (opción 2 correcta). Su aspecto es de una placa rojiza y aterciopelada.

Señale la actitud más correcta ante la sospecha de un flemón o absceso periamigdalino:

1. PAAF en paladar blando, claritromicina y corticoides iv.
2. PAAF en paladar blando, amoxicilina-clavulánico y corticoides iv.
3. TAC cuello sin contraste, amoxicilina-clavulánico y corticoides iv.
4. TAC cuello sin contraste, claritromicina y corticoides iv.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: Ante la sospecha de un flemón o absceso periamigdalino lo ideal es hacer una punción-aspiración con aguja fina para comprobar si hay colección o no.

En caso de pedir un TAC por dudas debería ser con contraste. El antibiótico de elección es un betalactámico.

Acude a Urgencias un paciente de 35 años que refiere odinofagia intensa, rebosamiento de saliva y voz engolada de dos días evolución, que en las últimas horas asocia sensación de cuerpo extraño laríngeo con progresiva disnea. A la exploración no presenta trismus ni empastamientos cervicales. La faringoscopia anterior muestra una hipertrofia amigdalar sin placas pultáceas, sin limitación a la apertura bucal. La movilidad lingual se encuentra conservada y el suelo de la boca no es doloroso, ni se encuentra afectado. A la laringoscopia indirecta se objetiva una epiglotis eritematosa y edematosa, con un punto de supuración de material purulento. El espacio respiratorio está claramente disminuido, pero es suficiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

1. En los adultos la exploración mediante laringoscopia indirecta, está absolutamente contraindicada dado que el riesgo de espasmo glótico es muy importante.
2. Es un cuadro absolutamente infrecuente tras la vacunación del *Haemophilus influenzae* tipo B.
3. Debe instaurarse una dieta absoluta y un tratamiento antibiótico, corticoideo y analgésico intravenoso, con ingreso hospitalario.
4. Los gérmenes más frecuentemente implicados son el *Streptococo pneumoniae* y *Pseudomona aeruginosa*.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La epiglotis aguda es un cuadro que puede darse tanto en niños como en adultos, siendo la exploración mediante laringoscopia indirecta en niños poco recomendable por el riesgo de espasmo glótico. En adultos, si la situación ventilatoria es adecuada, puede realizarse sin riesgo vital para el paciente. La vacunación del *H. influenzae* ha disminuido la incidencia de manera importante, pero sigue siendo un cuadro relativamente frecuente. Dado el riesgo de obstrucción de la vía aérea, requiere un tratamiento intravenoso hospitalario. Los gérmenes más frecuentemente implicados en él, aparte de *H. influenzae* son *Streptococo pyogenes* y *Staphylococcus aureus*. Opción 3 correcta.

En la parálisis facial de Bell, NO se halla:

1. Disgeusia.
2. Disacusia.
3. Hiposialia.
4. Diplopía.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Opción 4 correcta: La parálisis facial de Bell es una parálisis periférica y puede presentar, además de la lesión motora que afecta a la musculatura de la cara y según las fibras que afecte: disminución de la secreción lacrimal (nervio petroso superficial mayor), disacusia (nervio del músculo del estribo) y disgeusia de los 2/3 anteriores de la lengua e hiposialia (nervio de la cuerda del tímpano). Al ser una parálisis periférica no debe existir afectación de otros pares craneales como los del sistema oculomotor que provoquen diplopia.

-----o-----

Mujer de 67 años que acude a consulta por episodios de vértigo de segundos de duración que le dan principalmente en la cama cuando se gira a la izquierda desde hace un mes. Le cuesta levantarse porque le suele dar otra crisis de vértigo, pero el resto del día, si evita los movimientos bruscos de la cabeza se encuentra más o menos bien, quizás algo inestable. Si la maniobra de Dix-Halpike es positiva y de características periféricas, y teniendo en cuenta que no tiene artrosis cervical y está más o menos ágil, ¿cómo trataría a la paciente?

1. Sulpiride 10 días en dosis decreciente.
2. Diazepam 5 mg por la noche siete días.
3. Maniobra de liberación (Semont o Eppley).
4. Aspirina 100 mg al día de por vida.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Opción 3 correcta: Se describe la clínica típica de un vértigo posicional paroxístico benigno. El tratamiento de elección son las maniobras de liberación. Tienen una eficacia, hechas una o dos veces, de más del 90% en la curación del VPPB.

-----o-----

La sintomatología de inicio más frecuente en un paciente con neurinoma del acústico es:

1. Acúfenos, hipoacusia y dolor facial.
2. Ataxia y alteraciones del equilibrio.
3. Acúfenos únicamente.
4. Acúfenos, hipoacusia y alteraciones del equilibrio.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La clínica habitual de presentación del neurinoma del acústico es la hipoacusia retrococlear con acúfeno unilateral de larga evolución (opción 4 correcta). Puede presentar inestabilidad pero es muy rara la presencia de vértigo típico intenso. Un 10 % de los neurinomas debutan como sordera brusca. Cuando el tumor alcanza un tamaño considerable puede presentar dolor facial por afectación del V par o ataxia por

compresión cerebelosa.

-----O-----

Paciente de 60 años, VIH positivo, que, tras extracción dentaria del molar 47 por infección de la pieza dentaria, presenta disminución progresiva del nivel de conciencia y fiebre. En la última hora se añade dificultad para la apertura bucal y disnea, con inflamación del espacio submentoniano. ¿Cuál sería el diagnóstico MÁS probable y el siguiente paso?

1. Meningitis bacteriana – antibioterapia.
2. Angina de Ludwig – TAC con contraste, antibioterapia intravenosa y corticoides; asegurar la vía aérea y drenaje quirúrgico si se tratara de un absceso (si es flemonoso, el tratamiento médico suele ser suficiente).
3. Hematoma de suelo de boca – drenaje y antibioterapia.
4. Absceso cerebral – drenaje y antibioterapia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La angina de Ludwig es una urgencia odontológica que requiere antibioterapia urgente acompañada de traqueotomía, si pelagra la vía aérea, y drenaje quirúrgico, si se trata de una abscesificación (respuesta 2 correcta). Normalmente el desencadenante de este absceso del suelo de la boca es una infección dentaria, pero también puede aparecer tras una fractura mandibular. La clínica de *trismus* e inflamación submentoniana nos deben hacer pensar en esta patología, que es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos.

-----O-----

Un lactante de 5 meses presente rinorrea verdosa e inflamación palpebral derecha. Señale el diagnóstico más probable y su causa:

1. Absceso orbitario. Sinusitis etmoidal.
2. Celulitis. Sinusitis etmoidal.
3. Absceso subperióstico. Sinusitis frontal.
4. Absceso orbitario. Sinusitis maxilar.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Opción 2 correcta: El seno más afectado en los niños es el etmoides ya que otros senos como el frontal o el esfenoides tardan más tiempo en neumatizarse. La inflamación palpebral debe sugerirnos una celulitis.

-----O-----

La especial concentración iónica de la endolinfa se debe a la acción secretora del epitelio de:

1. Estría vascular.
2. Membrana de Reissner.
3. Órgano de Corti.
4. Saco endolinfático.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: La estría vascular se encuentra en la cara externa del conducto coclear y es donde se produce la endolinfa a partir de un filtrado activo procedente de la perilinfa. En el saco endolinfático se produce la reabsorción de la endolinfa. La composición de la endolinfa se parece a la de los líquidos intracelulares, con gran contenido en potasio, mientras que la perilinfa se asemeja al líquido cefalorraquídeo, con mayor cantidad de sodio. Recuerda que las alteraciones en la regulación de los electrolitos entre la endolinfa y la perilinfa dan lugar al hydrops endolinfático, implicado en la patogenia de la enfermedad de Ménière.

-----O-----

¿Cuál de estos músculos NO está innervado por el nervio laríngeo inferior o recurrente?

1. Cricotiroideo.
2. Cricoaritenoides posterior.
3. Tiroaritenoides.
4. Cricoaritenoides lateral.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Opción 1 correcta: El músculo cricotiroideo está innervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. El resto de músculos laríngeos los innerva el nervio laríngeo inferior o recurrente.

-----O-----

El edema de Reinke es:

1. Un edema agudo de laringe.
2. Una laringitis atrófica.
3. Un edema de cuerdas.
4. Un edema tubárico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Opción 3 correcta: El edema de Reinke, es una lesión benigna de la cuerda vocal debido a un proceso inflamatorio crónico a nivel del tejido conectivo de la capa superficial de la lámina propia, así ha recibido el nombre de laringitis crónica hipertrófica edematosa. Esta inflamación crónica es secundaria a hábito tabáquico, abuso vocal, reflujo gastroesofágico, abuso de alcohol, hipotiroidismo. Produce una tumefacción sésil de aspecto globulosos que se extiende en toda la superficie de ambas cuerdas vocales, y genera una disfonía crónica.

-----O-----

Con respecto a la rinitis, señale la afirmación CORRECTA:

1. Es una rinitis crónica hipertrófica.
2. Las fosas nasales suelen estar muy estrechadas.
3. Suele haber gran cantidad de costras.
4. El paciente se queja de gran humedad y rinorrea acuosa.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La ocrea es una rinitis atrófica asociada a cacosmia. El paciente es, en general, una mujer de edad joven y, con frecuencia, asiática. A pesar de la fetidez característica de las costras (respuesta 3 correcta), ella no tiene percepción de esta; en otras palabras, existe cacosmia con anosmia del que la padece. El tratamiento es igual que el de la rinitis seca (lavados nasales, hidratación) y, en casos resistentes, se realiza cirugía del vestíbulo nasal, que permita una reducción del tamaño de este y evite así la desecación (operación de Eyre).

-----o-----

Una de las siguientes enfermedades NO es causa de sordera de transmisión:

1. Otitis externa.
2. Otosclerosis.
3. Esclerosis múltiple.
4. Obstrucción del conducto auditivo externo.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En las hipoacusias de transmisión hay una patología en el oído externo o medio que afecta al mecanismo de amplificación y transmisión del sonido. Esta patología puede estar en el pabellón auricular (aplasia, hipoplasia.), en el CAE (tapón de cera, obstrucción por otorrea e inflamación, aplasia, hipoplasia), en la membrana timpánica (perforación, esclerosis.), en la caja (ocupación por serosa, pus, tumor) o en la cadena de huesecillos (luxación traumática, fijación por otosclerosis o inflamación). En las hipoacusias de percepción existe una lesión en la cóclea o en las vías auditivas (neurinoma, esclerosis múltiple.) por lo que marcamos la opción 3 correcta.

-----o-----

Tenemos una niña de 7 años de edad con antecedentes de fisura palatina. Presenta catarros de vías altas de repetición y otitis media crónica secretora bilateral, ¿Tendría indicación para adenoidectomía?

1. No tendría indicación de adenoidectomía.
2. Tendría indicación de adenoidectomía solo.
3. Tendría indicación de adenoamigdalectomía.
4. Tendría indicación de adenoidectomía y colocación de drenajes transtimpánicos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: Si la niña no tuviera una fisura palatina podría plantearse realizar una adenoidectomía además de la colocación de drenajes transtimpánicos.

La adenoidectomía en una niña con fisura palatina puede dejar una insuficiencia velopalatina, de ahí que la intervención no esté indicada.

Se le propondría realizar solo la colocación de drenajes transtimpánicos.

-----o-----

Respecto al cáncer de laringe en estadios 1 y 2 (precoz), es CIERTO que:

1. Salvo contraindicaciones, el tratamiento es quirúrgico conservador con láser o cirugía abierta convencional o radioterapia sola.
2. Se trata con quimioterapia de inducción seguido de cirugía.
3. Los taxanos tienen cada vez un papel mayor en su tratamiento.
4. La radioterapia postoperatoria es siempre necesaria.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: El tratamiento de elección del cáncer de laringe en estadio I y II es quirúrgico o radioterapia sola. Suele tratarse de forma profiláctica el cuello (con vaciamiento o radioterapia) en los tumores supraglóticos y subglóticos, no siendo necesario en los T1-T2/N0 de glotis.

-----o-----

Paciente de 25 años que, tras comer pescado, presenta sensación de cuerpo extraño faríngeo, con dolor. Acude a Urgencias, objetivándose una espina en base de lengua derecha. Señale la actitud CORRECTA:

1. Observación hospitalaria durante 24 horas.
2. Antibiótico durante siete días y vigilancia.
3. Extracción del cuerpo extraño con laringoscopia indirecta en Urgencias.
4. Extracción del cuerpo extraño con laringoscopia directa y anestesia general.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los cuerpos extraños faríngeos son una consulta habitual en el Servicio de Urgencias. Si se visualiza, se recomienda extracción directa o con laringoscopia indirecta (opción 3 correcta). Si esta fuese imposible, sería necesario hacerlo con anestesia general y laringoscopia directa. Si no se encuentra ningún cuerpo extraño, se indica observación domiciliaria asociada a analgesia y, si persisten síntomas, volver a Urgencias.

-----o-----

Varón que se encuentra de vacaciones en la playa, cuando comienza a presentar picor intenso y taponamiento en el oído izquierdo, motivo por el que acude a Urgencias. Entre sus antecedentes destaca que es hipertenso, trasplantado renal y tiene dermatitis atópica. Con respecto a la entidad que padece este paciente, es FALSO que:

1. La dermatitis es un factor predisponente.
2. El tratamiento es fundamentalmente tópico.
3. Los patógenos más frecuentes en estos procesos son Aspergillus y Mucor.
4. Estas infecciones son más frecuentes en nadadores.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La dermatitis atópica puede afectar también al conducto auditivo externo y facilitar la colonización por

patógenos bacterianos o fúngicos, siendo más frecuente en meses de verano. Habitualmente los cuadros bacterianos cursan con sintomatología dolorosa importante y los cuadros micóticos con predominio del picor. Los gérmenes más frecuentemente implicados en el caso de la micótica son *Candida* y *Aspergillus* (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Acude a la urgencia un paciente con una crisis de vértigo. Según nos cuenta, esta ha empezado cuando estaba con sus amigos en una discoteca y ha entrado a una sala "donde la música estaba muy fuerte". Presenta Rinne negativo en el oído derecho y Weber lateralizado a ese mismo lado. Por otoscopia no se observan alteraciones significativas. Sin embargo, cuando empieza a sonar la ambulancia cerca de él, comienza a presentar un nistagmo de carácter periférico. Señala el diagnóstico más probable:

1. Vértigo migrañoso.
2. Síndrome de dehiscencia del canal semicircular superior o de Minor.
3. Laberintitis.
4. Síndrome posicional paroxístico benigno.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de dehiscencia de canal semicircular superior (DCSS) o síndrome de Minor se caracteriza por crisis de vértigo inducidas por sonidos de alta intensidad (signo de Tullio), como es el caso, o por incrementos de presión en el oído (signo de Hennebert). Los pacientes suelen presentar autofonía (malestar por la percepción de la propia voz). En la audiometría aparece una hipoacusia de transmisión y el examen al otoscopio es normal. En las pruebas vestibulares encontramos nistagmo y vértigo inducido por sonidos de intensidad o en respuesta a cambios de presión. El diagnóstico se complementa con TAC y el tratamiento es farmacológico, rehabilitación y, en último lugar, cirugía.

-----O-----

¿En cuál de estas afecciones tiene mayor importancia la existencia de un uso incorrecto de la voz?

1. En los nódulos laríngeos.
2. En el pólipo de cuerda vocal.
3. En el papiloma.
4. En la parálisis recurrencial.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

De las cuatro, las dos patologías relacionadas con el esfuerzo vocal son los nódulos vocales y el pólipo vocal. De estas dos, la más relacionada son los nódulos vocales, más típicos de mujeres y de profesionales de la voz, pudiendo ser considerada como enfermedad profesional y además su tratamiento de elección es con técnicas de reeducación vocal (opción 1 correcta). La exéresis mediante microcirugía laríngea es utilizada cuando fracasaron los tratamientos logopédicos, y complementándose con éstos. Los pólipos de cuerda vocal son más frecuentes en varones, tras esfuerzos vocales bruscos durante episodios catarrales, sobre todo si coexisten con exposición al tabaco. Su tratamiento de elección es quirúrgico.

El papiloma se relaciona etiológicamente con el virus papiloma humano (HPV) sobre todo tipos 6 y 11. Las parálisis del nervio laríngeo inferior o recurrente, se producen por tumores, traumatismos accidentales o actos quirúrgicos, a nivel cervical y torácico, siendo la causa más frecuente la cirugía tiroidea.

Acude a su consulta un paciente de 27 años con un Síndrome de Down bastante severo que indica con gestos que no oye bien, no parece haber ninguna otra sintomatología asociada. ¿Cuál cree usted que sería la prueba más útil a realizar?

1. Resonancia magnética nuclear
2. Potenciales evocados de tronco auditivo
3. TAC de peñascos
4. Audiometría tonal y verbal

Resp. Correcta: 2

Comentario: Inicialmente en estos casos se debería hacer una prueba de audición, para poder objetivar si existe o no la hipoacusia. Inicialmente se harían unos diapasones para determinar el Rinne y Weber, y una audiometría tonal y verbal. En un chico con síndrome de Down SEVERO una respuesta fiable en estas pruebas puede ser dudosa, porque son pruebas SUBJETIVAS. Por eso sería necesario realizar una prueba objetiva como son los potenciales evocados (Respuesta 2 correcta). Las pruebas de imagen como el TAC o la RNM se harían, pero posteriormente una vez fundamentada la existencia de una hipoacusia para poder encontrar una posible causa.

Niño de 6 meses que no superó el screening auditivo, y que se confirma que sufre de una sordera profunda bilateral (mayor de 90dB en frecuencias conversacionales y una discriminación verbal menor del 20%), con integridad anatómica de la cóclea demostrada mediante TAC y RMN. ¿Qué tratamiento propondría para evitar que sea sordomudo?

1. Implante coclear, si es posible bilateral.
2. Prótesis auditivas convencionales.
3. Vasodilatadores.
4. No existe posibilidad de tratamiento.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Este niño sería candidato para un implante coclear (opción 1 correcta). En el caso de persistir la hipoacusia profunda bilateral y no proporcionar de alguna forma estímulos auditivos, el niño no va a desarrollar el habla y será sordomudo. El implante coclear es un dispositivo electrónico capaz de convertir la energía mecánica sonora en señales eléctricas que serán suministradas al nervio auditivo en aquellos pacientes con sordera neurosensorial profunda de origen coclear. Es la única opción cuando no se pueden adaptar prótesis auditivas al ser la hipoacusia profunda. Antes de realizar un implante coclear, es necesario realizar una serie de pruebas para comprobar si el niño es o no candidato a implante coclear. Para ello, es fundamental realizar pruebas audimétricas (audiometría, otoemisiones, PEAT), pruebas de imagen para valorar la permeabilidad coclear (RM y TC) y una valoración logopédica. Lo ideal es implantar ambos oídos para tener una audición binaural (a pesar del mayor costo económico).

-----O-----
Paciente con perforación timpánica bilateral conocida. Acude por tapón de cera. ¿Cuál es su actitud?

1. Lavado con agua.
2. Derivar a ORL para extracción en seco.
3. Administrar gotas antibióticas y luego lavar con agua.
4. Lavado con agua y luego administrar alcohol boricado.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Opción 2 correcta: Los oídos con perforación timpánica no deben mojarse nunca. Se deben de limpiar por parte de ORL con aspiración y pinzas. Si hay sobreinfección aguda, además de la antibioterapia sistémica, se suele aplicar tratamiento tópico para tratar la infección directamente a la caja timpánica.

-----O-----
Acude a su consulta una paciente de 28 años por dolor en el suelo de la boca cada vez que come e inflamación del mismo. A la exploración se ve un conducto de Wharton inflamado con un área de 1 cm dura a la palpación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Adenoma pleomorfo de glándula submaxilar.
2. Carcinoma adenoide quístico submaxilar.
3. Sialolitiasis submaxilar.
4. Ránula.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Opción 3 correcta: La sialolitiasis submaxilar se caracteriza por inflamación y dolor en suelo de boca que aumenta con la ingesta propia del cálculo que se ha formado.

-----O-----
La amigdalectomía está indicada en UNA de las siguientes patologías. Señálela:

1. Angina de Schulttz.
2. Amigdalitis aguda no complicada.
3. Angina de Vincent.
4. Abscesos periamigdalinos de repetición.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Un primer absceso periamigdalino no constituye una indicación de amigdalectomía, pero sí los abscesos de repetición (respuesta 4 correcta). Veamos las demás opciones:

- 1.- La angina agranulocítica de Schulttz se produce en el contexto de la neutropenia, a veces inducida por fármacos como antitiroideos. Es más frecuente en pacientes de edad avanzada. Se caracteriza por síntomas sistémicos de gravedad, ulceraciones y necrosis de las amígdalas, así como dolor severo. El tratamiento se realiza con penicilina más transfusión sanguínea.
- 2.- La amigdalitis bacteriana aguda no complicada se trata con penicilinas de amplio espectro (amoxicilina a

dosis elevada +/- ácido clavulánico). Por supuesto, un episodio aislado de amigdalitis aguda sin complicaciones no requiere tratamiento quirúrgico.

3.- La angina de Vincent, producida por una asociación fusoespirilar, es de buen pronóstico y se trata con penicilinas de amplio espectro (S. pyogenes).

La mononucleosis infecciosa, producida por el virus de Epstein-Barr, tiene tratamiento sintomático, vigilando la función hepática por afectación de la misma.

-----O-----

Una paciente consulta al otorrino por hipoacusia y otorrea resistente a los tratamientos convencionales. Por otoscopia, destaca una imagen blanquecina atical. El diagnóstico más probable será:

1. Otitis media crónica simple.
2. Otitis media aguda.
3. Petrositis.
4. Colesteatoma.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La otitis crónica se manifiesta generalmente con episodios de otorrea y por hipoacusia, no siendo habitual la otalgia como en la otitis media aguda. Ciertas lesiones que aparecen en la exploración otoscópica son indicativas de que existe un colesteatoma: una perforación en la pars flaccida con otorrea o escamas blanquecinas propias del colesteatoma, un pólipo o un tapón de cera en el ático, una perforación que afecte al marco timpánico erosionándolo o escamas de epitelio provenientes de la caja, generalmente con supuración (opción 4 correcta).

La otomycosis se caracteriza por prurito y otorrea cremosa, la otitis media aguda por otalgia intensa y, en ocasiones, perforación de la pars tensa, la petrositis por dolor retroorbitario y diplopia por parálisis del VI par (síndrome de Gradenigo).

-----O-----

Paciente de 57 años, sin antecedentes de interés, que al levantarse por la mañana presenta una sordera completa de oído derecho, acúfenos e inestabilidad. Lo MÁS probable es que tenga:

1. Una otoscopia normal.
2. Un tímpano enrojecido.
3. Un tapón de cera.
4. Un tímpano perforado.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante la sintomatología comentada debemos sospechar una hipoacusia súbita idiopática, que es un problema coclear, y por tanto, nos da una otoscopia normal (respuesta 1 correcta). Aunque la hipoacusia puede ser aislada, con frecuencia asocia acúfenos y menos frecuentemente, inestabilidad.

-----O-----

Paciente de 45 días de vida, que desde los primeros días de vida presenta un ruido durante la inspiración que aumenta con el llanto, evidenciando una saturación de oxígeno constante y una coloración de las mucosas adecuadas. Acuden los padres a su consulta muy preocupados porque, a pesar de su progresiva mejoría, el ruido inspiratorio persiste. Respecto a la patología del neonato, indique lo FALSO:

1. Se trata de la patología congénita laríngea más frecuente (alrededor del 75%) que se corrige espontáneamente en pocos meses, requiriendo solo en algunas ocasiones tratamiento quirúrgico.
2. En la exploración directa podrá objetivarse una tumoración de coloración rojiza, situada en la subglotis, provocando una clínica obstructiva en 2/3 de los casos.
3. En la exploración, el niño presenta un crecimiento adecuado, se ve saludable y no evidencia signos de dificultad respiratoria (aleteo nasal, tiraje supraclavicular o intercostal, cianosis).
4. Su etiopatogenia radica en la hiperlaxitud del esqueleto laríngeo, que ante presiones negativas se colapsa, provocando estridor inspiratorio.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El caso clínico retrata el típico caso de **Laringomalacia**, patología laríngea congénita más frecuente. En la exploración (laringoscopia flexible) podremos hallar un alargamiento y extensión lateral de la epiglotis (en forma de omega) que se aspira en la inspiración o unos aritenoides redundantes con prolapso anteromedial. A pesar de ello, las cuerdas vocales presentarán una estructura y función normal en los pacientes con laringomalacia. La respuesta 2 correcta, se refiere a una hemangioma congénito subglótico, que es altamente infrecuente, que no mejora espontáneamente y asocia en un 70% de los casos clínica obstructiva, en forma de disnea.

-----O-----

Le llaman a las 2 de la madrugada porque hay un paciente en Urgencias que se está asfixiando. La enfermera le tiene preparado un gotero con teofilina y un bisturí para realizar una traqueotomía. Sin dudarle, usted elige el bisturí porque:

1. El paciente presenta estridor espiratorio y signos evidentes de edema pulmonar.
2. El paciente está muy cianótico.
3. El paciente está taquicárdico y sudoroso.
4. El paciente presenta estridor inspiratorio y tiraje.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El estridor inspiratorio es un signo de típico de obstrucción respiratoria alta, principalmente a nivel de la laringe, hipofaringe y orofaringe. La presencia además de tiraje hace pensar en que el paciente se está agotando, lo que conlleva un elevado riesgo de parada respiratoria, por lo que el tratamiento en estos casos en superar el nivel de la obstrucción creando una ventada traqueal (en el segundo o tercer anillo) por la que el paciente pueda respirar sin esfuerzo; es decir, realizar una traqueotomía urgente (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Paciente de 82 años, fumador y bebedor importante, que consulta porque desde hace meses nota una sensación extraña al tragar, parestesias faríngeas y una adenopatía

cervical. ¿Qué debemos sospechar?

1. Carcinoma de cuerda vocal.
2. Carcinoma supraglótico.
3. Cáncer de *cavum*.
4. Carcinoma subglótico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Ante un paciente con factores de riesgo (tabaco y alcohol) que presenta molestias faríngeas inespecíficas (parestesias, disfagia, etc.), otalgia refleja y una adenopatía cervical siempre hay que descartar un carcinoma supraglótico (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Acude a nuestra consulta una mujer de 43 años, maestra en una escuela primaria, por disfonía. En la fibrolaringoscopia apreciamos la existencia de una lesión bilateral y simétrica en la parte anterior de las cuerdas vocales. El diagnóstico más probable es:

1. Edema de Reinke.
2. Pólipos vocales.
3. Paquidermia de contacto.
4. Nódulos vocales.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta fácil sobre la patología benigna de la laringe. Nos presentan una paciente que realiza un abuso prolongado de la voz y que presenta disfonía. La imagen de una lesión bilateral en la parte anterior de las cuerdas vocales es compatible con los "kissing nodes" de los nódulos vocales (opción 4 correcta). No debemos confundirnos con la paquidermia de contacto, cuyas lesiones serían en la parte posterior de las cuerdas vocales.

-----O-----

Paciente mujer de 32 años que presenta clínica de obstrucción nasal unos 5 días a la semana, con estornudos en salvas y rino-hidrorrea desde hace 2 meses. No puede realizar ejercicio físico y le cuesta dormir. Tiene pruebas cutáneas positivas para distintos pólenes y ácaros del polvo. Según la nueva clasificación de las rinitis, el diagnóstico sería:

1. Rinitis alérgica intermitente moderada-grave.
2. Rinitis alérgica persistente moderada-grave.
3. Rinitis no alérgica persistente moderada-grave.
4. Rinitis no alérgica intermitente moderada-grave.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata de una rinitis crónica alérgica que, dados los días de la semana y los meses que lleva así, con una afectación que le limita realizar deporte y el descanso, se etiqueta de rinitis crónica persistente moderada-

grave (respuesta 2 correcta).

Se adjunta una tabla de la nueva clasificación de las rinitis.

-----O-----

Varón de 60 años, fumador y bebedor habitual, que refiere odinofagia de tres semanas de evolución que no responde a tratamiento analgésico. En la exploración presenta una ulceración pequeña confinada en la amígdala derecha, que es biopsiada e informada como carcinoma epidermoide. La exploración cervical clínica y radiológica no presenta adenopatías. Respecto al tratamiento, señale lo CORRECTO:

1. Se puede realizar cirugía con resección completa amigdalar + vaciamiento cervical, o radioterapia, ya que ambas tienen la misma eficacia.
2. Se debe realizar protocolo de organopreservación con quimiorradioterapia.
3. Se debe realizar quimioterapia por su menor morbilidad e igual eficacia que la cirugía en este caso.
4. No es necesario el tratamiento del cuello al no haber adenopatías.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de los tumores de orofaringe en estadio precoz (estadio I y II), pueden ser tratados con radioterapia en tumor y cadenas cervicales, o con cirugía + vaciamiento cervical profiláctico (a pesar de ser N0, en los tumores de orofaringe siempre hay que tratar el cuello) por lo que marcamos la opción 1 correcta. En estadios avanzados se puede mantener el tratamiento quirúrgico, generalmente más agresivo, que requiere reconstrucciones con colgajos y en ocasiones faringolaringectomías totales, o protocolo de órgano preservación basado en quimiorradioterapia. En caso de metástasis a distancia, a nivel pulmonar casi siempre, el tratamiento es paliativo con quimioterapia.

-----O-----

Esta usted de guardia en Urgencias pediátricas y a la 1.30 de la madrugada llega una madre muy preocupada porque su hijo se ha desvelado con ‘pitos’ al respirar. Dice que el niño ha empezado bruscamente a tener dificultad para respirar, y, en palabras de la madre, ‘parece que se va a quedar sin aire’. Anamnesis: varón de 2 años con infección respiratoria banal los días previos. EF: buen estado general, afebril y estridor inspiratorio marcado. Respecto al cuadro que usted sospecha, indique la actuación más acertada:

1. Humidificación ambiental.
2. Humidificación ambiental + intubación.
3. Humidificación ambiental + penicilina.
4. Humidificación ambiental + ceftriaxona.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico en el que para poder contestar correctamente debemos identificar primero el cuadro que nos presentan.

Se trata de una laringitis estridulosa o espasmódica o pseudocrup. Lo más importante de esta patología es saber hacer el diagnóstico diferencial con la epiglotitis (nos contarán un niño de 2 a 6 años con marcada postración, fiebre elevada, disnea intensa, babeo y posición de sedestación) y con la laringitis glotosubglótica o crup (nos contarán un niño menor de 3 años con fiebre que progresivamente comienza con disnea, voz ronca, tos perruna, estridor inspiratorio y buen estado general).

La respuesta correcta es la 1. La laringitis estridulosa cede sola o con humidificación ambiental, aunque puede recurrir.

Veamos opción por opción:

- 2) A priori, el niño que nos presentan no requiere intubación. Aunque sea un cuadro muy llamativo y que asusta mucho a los padres, no existe compromiso de la vía aérea como para requerir intubación.
- 3) La laringitis estridulosa no requiere tratamiento antibiótico. Esta opción sería correcta ante la sospecha de una laringitis diftérica.
- 4) Repito, la laringitis estridulosa no requiere tratamiento antibiótico. La ceftriaxona es el tratamiento de la epiglotitis.

-----o-----

Señale la relación falsa, entre patología y tratamiento inicial, de las siguientes:

- 1. Otitis media serosa-Tratamiento médico antibiótico
- 2. Otoesclerosis- Tratamiento quirúrgico
- 3. Presbiacusia- Adaptación audioprotésica
- 4. Otitis media aguda-Tratamiento médico antibiótico

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La otitis media serosa se suele producir como consecuencia de algún episodio de congestión nasal. Habitualmente el tratamiento de la obstrucción nasal, mediante descongestionantes y/o antiinflamatorios, conlleva la mejoría progresiva de los síntomas auditivos por lo que marcamos la opción 1 correcta. La otoesclerosis es una enfermedad que provoca la fijación del estribo. El tratamiento más recomendado es la cirugía. La presbiacusia o hipoacusia por desgaste asociado a la edad requiere, según su intensidad, de adaptación audioprotésica. La otitis media aguda, es un cuadro infeccioso de la caja timpánica cuyo tratamiento precisa de terapia antibiótica.

-----o-----

Varón de 70 años, con antecedentes de DMNID, HTA y DL, que acude remitido a su consulta de Urgencias por sus familiares, que refieren que, desde hace dos semanas, presenta un fuerte dolor en oído derecho que tras unos días se acompañó de secreción por ese oído, que no remite con el tratamiento antibiótico oral y tópico que pautó su médico de cabecera. En su exploración clínica usted detecta una evidente desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo y dificultad en el cierre ocular derecho. ¿Cuál

cree que sería la actitud MÁS indicada en esta situación?

1. Otoscopia, ingreso, ciprofloxacino i.v.
2. Otoscopia, ingreso, Gammagrafía Tc-99, ciprofloxacino v.o.
3. Otoscopia, ingreso, TC, ciprofloxacino i.v., además de protección ocular y corticoterapia.
4. Otoscopia, TC, ciclo de ciprofloxacino i.v, revisión ambulatoria, además de protección ocular y corticoterapia.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

No deberías haber tenido problemas para identificar el cuadro clínico, ya que se trata de una otalgia con otorrea en un anciano diabético con mal estado general y que asocia una afectación del VII par craneal. El cuadro resulta muy sugestivo de otitis externa maligna. Ante la actitud a llevar a cabo, la opción de respuesta 3 es la más acertada, ya que esta patología requiere un manejo hospitalario prolongado mediante antibioterapia, antipseudomonas intravenosa y realización de una TC para comprobación del nivel de afectación en base de cráneo. Es también importante añadir tratamiento para la mejoría de la parálisis facial (corticoterapia y protección ocular).

-----o-----

Varón de 51 años que acude a Urgencias por aparición hace 2 días de lesiones vesiculosas en pabellón auricular derecho, que se acompañaban de otalgia. Desde hace unas horas nota sensación de tener la boca torcida hacia la izquierda. El diagnóstico más probable es:

1. Parálisis facial de Bell izquierda.
2. Parálisis facial de Bell derecha.
3. Síndrome de Heerfordt.
4. Síndrome de Ramsay-Hunt.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La aparición de vesículas en el CAE o en la concha del pabellón auditivo durante una parálisis facial es diagnóstico del Síndrome de Ramsay- Hunt. Suele acompañarse de otalgia y si afecta también al VIII par se produce hipoacusia perceptiva, acúfeno y vértigo (opción 4 correcta). La parálisis de Bell, afrígore o idiopática, es la más frecuente de la parálisis faciales periféricas y no se asocia a otro síntoma salvo la parálisis. El síndrome de Heerfordt es una manifestación extrapulmonar de la sarcoidosis donde se asocia la parálisis facial periférica con uveítis y parotiditis. El síndrome de Melkersson- Rosenthal se caracteriza por parálisis faciales periféricas idiopáticas de repetición en un lado o los dos de la cara, en ocasiones de forma simultánea. Se acompaña de edema facial y lengua fisurada.

-----o-----

La parálisis del nervio laríngeo superior se manifiesta por:

1. Sólo disfonía
2. Disnea y disfonía
3. Episodios de aspiración por pérdida de sensibilidad larínea
4. Voz bitonal

Resp. Correcta: 3

Comentario: El nervio laríngeo superior es la rama del nervio vago que se encarga de la sensibilidad de la laringe. Por tanto una lesión a este nivel cursará con episodios de aspiración por pérdida de sensibilidad laríngea lo que impide que se desencadene el reflejo tusígeno, por lo que marcamos la opción 3 correcta.

-----O-----

Un paciente con parálisis facial periférica que presenta un test de lacrimación (Schirmer) normal y un reflejo estapedial abolido, sugiere una lesión en:

1. La primera porción del facial.
2. La segunda porción del facial.
3. La tercera porción del facial por debajo de la salida de la cuerda del tímpano.
4. El nervio facial parotídeo.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Opción 2 correcta: Si la lesión se encontrara a nivel del CAI estaría afectado todo el nervio facial, y por tanto no tendría un test de Schirmer normal. Si la lesión estuviera en la primera porción del nervio facial ocurriría lo mismo. Si la lesión fuera distal a la cuerda del tímpano el reflejo estapedial estaría normal, puesto que la rama que va al músculo del estribo se encuentra proximal al nervio cuerda del tímpano. Si la porción alterada fuese la porción intraparotídea tanto la lacrimación como el reflejo estapedial estarían normales

-----O-----

Una exploración audiométrica en un paciente con una hipoacusia neurosensorial se caracteriza por:

1. Gap óseo-aéreo.
2. Afectación preferente de frecuencias graves.
3. Buena discriminación.
4. Afectación preferente de frecuencias agudas.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En la audiometría tonal una hipoacusia de percepción o neurosensorial se caracteriza por presentar un umbral auditivo disminuido tanto de la audición por vía ósea como de la vía aérea, sin diferencia o GAP óseo- aéreo. La mayoría de las hipoacusias de percepción presentan una afectación mayor en las frecuencias agudas (la enfermedad de Meniere es la excepción al afectarse más las frecuencias graves) opción 4 correcta. La hipoacusia de transmisión presenta GAP óseo- aéreo, siendo la audición por vía ósea normal y disminuida por vía aérea. En la audiometría verbal la hipoacusia de percepción presenta una mala discriminación mientras que la de transmisión la tiene normal.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo para desarrollar una lesión maligna en cavidad oral?

1. Tabaco
2. Roce crónico de prótesis dental
3. Consumo crónico de alcohol
4. Virus de Epstein-Barr

Resp. Correcta: 4

Comentario: El factor de riesgo más importante para el desarrollo de lesión maligna oral es el consumo de tabaco. El alcohol multiplica el riesgo del tabaco. También el roce crónico con una prótesis dental puede provocarlo. El virus del papiloma oral también se ha relacionado con el desarrollo de tumores orales, aunque menos frecuente que en la orofaringe. El virus de Epstein-Barr está implicado en el desarrollo del carcinoma de cavum, por lo que marcamos la opción 4 correcta.

-----O-----

Mujer de 25 años que acude a Urgencias porque refiere que, de forma brusca, ha dejado de escuchar por el oído derecho al poco tiempo de despertar. Además refiere presencia de pitidos continuos en el mismo oído. A la exploración tiene una otoscopia normal, presenta una acimetría con Rinne positivo bilateral y Weber lateralizado hacia el oído izquierdo. No refiere cuadros similares. ¿Cuál es su Sospecha - Tratamiento INICIAL?

1. Hipoacusia súbita - Corticoides sistémicos.
2. Laberintitis - Implante coclear.
3. Otosclerosis - Estapedectomía.
4. Síndrome de Ménière - Vasodilatadores.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Opción 1 correcta: La sordera brusca o hipoacusia súbita es una entidad de causa desconocida, aunque algunos estudios la han relacionado con una infección vírica 1-2 semanas antes de su aparición. Aunque el pronóstico de recuperación es bueno y no se influye demasiado por el tratamiento, este consiste en esteroides (para disminuir el supuesto componente inflamatorio). La pista de la hipoacusia neurosensorial la da la acimetría (Rinne positivo y Weber hacia el lado sano). En consulta se debería confirmar la hipoacusia neurosensorial con una audiometría y solicitar una RMN para descartar patología del APC, como un neurinoma, que pudiera manifestarse de manera similar a esta patología.

-----O-----

El reclutamiento como signo típicamente endococlear:

1. Se presenta en un 12-20% de los neurinomas del acústico.
2. El reclutamiento es un signo de sordera retrococlear.
3. La existencia de reclutamiento excluye el diagnóstico de neurinoma.
4. El reclutamiento sólo se presenta en las sorderas cocleares.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El reclutamiento es un signo de afectación endococlear y aparece en las hipoacusias de percepción con lesión coclear. En las hipoacusias retrococleares no existe reclutamiento y sí fatiga y adaptación patológica. En el neurinoma es típica la hipoacusia retrococlear pero en un 12- 20% de los casos puede presentarse como sordera brusca con afectación coclear(Opción 1 Correcta). Esta presentación se piensa que corresponde a la isquemia coclear producida por lesión de la arteria laberíntica por edema o hemorragia intracanalicular del tumor, a veces de pequeño tamaño. Es en estos casos donde existe reclutamiento en el neurinoma.

El escotoma en la audiometría tonal a 4000 Hz monoaural es típico de:

1. Trauma acústico agudo.
2. Trauma acústico crónico.
3. Ototoxicidad.
4. Sordera súbita.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Una hipoacusia neurosensorial con escotoma centrado en la frecuencia de 4000 Hz es casi patognomónico de trauma acústico agudo (Opción 1 correcta). En el trauma acústico crónico aparece una pérdida de audición en todas las frecuencias agudas con una curva de configuración descendente, que puede afectar en estados avanzados también a las frecuencias conversacionales. La ototoxicidad y la sordea súbita suelen tener también curvas de aspecto descendente. En la conmoción laberíntica la hipoacusia se acompaña generalmente de alteración en el equilibrio.

-----O-----

Paciente de 39 años que acude por parálisis facial derecha completa de instauración brusca, sin otras alteraciones acompañantes. Toda la musculatura de la hemicara derecha está afectada. La etiología MÁS probable del cuadro clínico será:

1. Idiopática.
2. Tumoral.
3. Por otitis media.
4. Síndrome de Melkersson-Rosenthal.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un claro caso de parálisis facial. Debes recordar que la causa más frecuente es idiopática (opción 1 correcta), con el epónimo de Bell o parálisis facial a frigore. Recuerda que el tratamiento es médico, con corticoides, para disminuir este edema, lo que acorta el tiempo de recuperación y protección ocular. La segunda causa más frecuente serían las de origen traumático, por fracturas temporales o heridas faciales, que afecten al nervio facial en su trayecto. También puede lesionarse durante intervenciones quirúrgicas. El síndrome de Ramsay-Hunt no es otra cosa que el herpes-zóster, ótico. Inicialmente, produce intensa otalgia, y después de 2 a 3 días aparecen las primeras vesículas en el conducto auditivo externo y en el pabellón auricular. En este caso, habría que instaurar tratamiento antivírico con aciclovir o derivados.

-----O-----

Una de las siguientes respuestas es falsa respecto a la neuronitis vestibular:

1. Se caracteriza por una crisis de vértigo.
2. En la electronistagmografía hay hipo o arreflexia vestibular.
3. Se afecta la primera neurona del nervio vestibular.
4. Se acompaña de hipocusia y acúfenos.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La neuronitis vestibular es un proceso que afecta sólo al nervio vestibular del VIII par craneal, por lo que presenta vértigo y no síntomas auditivos (opción 4 correcta). La etiología se piensa que puede ser vírica o infecciosa y afecta a la primera neurona del nervio vestibular que disminuye o cesa en su función

provocando hipo o arreflexia vestibular. Clínicamente se presenta como una crisis intensa de aparición brusca que irá mejorando en el curso de días o semanas.

La angina de Ludwig es:

1. Una infección del suelo de la boca y espacios submandibulares potencialmente grave por el posible compromiso de la vía aérea.
2. Una infección del suelo de la boca y espacios submandibulares potencialmente grave por su extensión al seno cavernoso.
3. Una forma de amigdalitis por anaerobios.
4. Su origen habitual es un absceso retrofaríngeo.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta muy fácil sobre la definición de la Angina de Ludwig. La angina de Ludwig (AL) es una entidad patológica, odontogénica e infecciosa que representa una situación de emergencia por comprometer la vida del paciente debido a una progresiva oclusión de la vía aérea, producto del avance de la infección de origen dentario hacia los espacios submandibulares, sublinguales y submental, lo que trae como consecuencia el colapso de la misma. Opción 1 correcta.

El síntoma más frecuente de la otomicosis es:

1. Hipoacusia.
2. Otorrea.
3. Otorragia.
4. Prurito.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La otomicosis o infección por hongos del conducto auditivo externo se caracteriza principalmente por el prurito ótico (opción 4 correcta). Aparece generalmente como una sobreinfección tras un tratamiento con antibióticos tópicos y se debe pensar en ella siempre que una infección no mejore con terapia antibiótica. Puede presentar un exudado algodonoso (cándidas), en ocasiones de color gris negruzco (Aspergillus). La obstrucción del CAE por este exudado puede producir hipoacusia de transmisión.

Una mujer de 30 años consulta por sordera de larga duración que empeoró en su último embarazo. En su historia destaca el antecedente familiar materno de sordera. El diagnóstico será:

1. Tuberculosis ótica.
2. Otosclerosis.
3. Conmoción laberíntica.
4. Síndrome de Mondini.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La historia clínica habitual de la otosclerosis es la de una hipoacusia progresiva en una mujer iniciada a partir de los 20 años, que empeora con los embarazos y con historia familiar de hipoacusia (opción 2 correcta). La hipoacusia suele ser de transmisión y puede presentar acúfeno y mareo ocasional. La exploración otoscópica es normal. La tuberculosis ótica se debe sospechar ante una otitis media crónica que no responda al tratamiento habitual, la conmoción laberíntica aparece después de un traumatismo, el glomus timpánica presenta una masa rojiza pulsátil que abomba la membrana timpánica. La malformación del síndrome de Mondini cursa con hipoacusia neurosensorial severa desde etapas tempranas de la vida.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes características no aparece en la hipoacusia del neurinoma del acústico?

1. Alteración de la inteligibilidad (disociación tonal-verbal)
2. Weber lateralizado al oído sano
3. Fenómeno de reclutamiento
4. Fenómeno de fatiga

Resp. Correcta: 3

Comentario: Si en esta pregunta usamos técnica de examen vemos que la opción 3 y 4 son muy parecidas, por lo que la duda estará entre esas dos. La opción 3 la marcamos por se la correcta, es típica de la hipoacusia de percepción coclear y la 4 de hipoacusia de percepción retrococlear. En el caso del neurinoma del acústico la hipoacusia es retrococlear, con disociación tonal-verbal, sin reclutamiento y con fenómeno de fatiga (se necesita mayor intensidad para oír bien). Las opciones 1 y 2 son típicas de todas las hipoacusias de percepción.

-----o-----

Una paciente con fiebre y mal estado general presenta en la exploración un empastamiento doloroso del suelo de la boca, desde hace tres días. Existe franco abombamiento de la región submentoniana. En relación a la enfermedad que sospecha, es cierto que:

1. Si presenta agranulocitosis, se hablaría de angina de Schultze.
2. Se trata de una angina de Plaut-Vincent, producida por anaerobios y espiroquetas.
3. El diagnóstico más probable es el de herpangina, producida por el virus Cocksackie A.
4. Probablemente esté en relación con mal estado dentario.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En esta pregunta nos describen una angina de Ludwig o absceso del suelo de la boca (submentoniano). Cursa con dolor y tumefacción en el suelo de la boca y su origen suele ser un mal estado dentario. El tratamiento incluye desbridamiento quirúrgico y antibióticos de amplio espectro que cubra anaerobios. Por tanto la respuesta correcta es la 4.

-----o-----

Varón de 58 años, sin antecedentes personales de interés, salvo cuadros repetitivos de infecciones de vías respiratorias altas, así como secuelas de otitis media crónica, con perforación timpánica izquierda tratada quirúrgicamente, que es derivado a la

consulta de ORL por presentar otorrea en tres ocasiones en los dos últimos meses de manera esporádica, escasa, de oído derecho, acompañado de hipoacusia bilateral leve no progresiva. Niega cefalea, otalgia, mareo y otros datos neurológicos. A la exploración física se observa oído izquierdo con conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, opaca, movilidad presente. Oído derecho con conducto auditivo externo permeable, membrana timpánica íntegra, conservando cono luminoso, coloración normal, movilidad presente. Rinne positivo bilateral y Weber central. Audiometría con hipoacusia bilateral media mixta de predominio conductivo. TC: masa en el lado derecho de la base del cráneo que erosiona el hueso occipital. Con respecto al tratamiento quirúrgico del colesteatoma, ¿cuál es la finalidad PRIMORDIAL del mismo?

1. Evitar complicaciones.
2. Mejorar la agudeza auditiva.
3. Eliminar la otorrea.
4. Evitar la malignización.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La indicación principal para intervenir quirúrgicamente un colesteatoma es evitar complicaciones (respuesta 1 correcta). La peligrosidad del colesteatoma está relacionada con las propiedades osteolíticas y el carácter evolutivo, que puede causar complicaciones graves. El tratamiento consiste en resecar el colesteatoma y efectuar, en la mayoría de los casos, una reconstrucción del oído.

-----O-----

Seleccione la relación “patología-tratamiento” falsa de las siguientes.

1. Síndrome de Meniere - Dieta pobre en sal
2. Neuritis vestibular - Corticoides
3. Vértigo posicional paroxístico benigno - Sedantes vestibulares
4. Laberintitis - Tratamiento antibiótico

Resp. Correcta: 3

Comentario: El vértigo posicional paroxístico benigno es la forma más frecuente de vértigo periférico y su tratamiento no se realiza mediante sedantes vestibulares. Dado que la causa es la presencia de una otoconia en el interior de un canal semicircular, el tratamiento más adecuado es la reubicación de dicha partícula mediante maniobras, opción 3 correcta.

-----O-----

Señale en cuál de los siguientes cánceres se ha demostrado una mayor asociación con el VPH

1. Carcinoma epidermoide de orofaringe
2. Linfopitelioma de Cavum
3. Adenocarcinoma de etmoides
4. Carcinoma epidermoide de hipofaringe

Resp. Correcta: 1

Comentario: Aunque el VPH se ha relacionado con el cáncer de laringe o hipo faringe, es en el carcinoma epidermoide de oro faringe donde se ha demostrado una mayor asociación (opción 1 correcta). El tipo de pacientes con carcinoma epidermoide asociado a VPH es más joven (30-55 años) y con mayor afectación de varones. A pesar de una mayor agresividad (manifestada por una extensión linfática más precoz), estos tumores presentan un pronóstico más favorable que los no asociados a VPH (su respuesta al tratamiento de órgano preservación con quimiorradioterapia es más favorable), además de tener menos tendencia a desarrollar segundos tumores primarios en otras localizaciones.

-----O-----

El absceso periamigdalino es la complicación más frecuente de la amigdalitis aguda. Respecto al mismo, señale la afirmación CORRECTA:

1. La úvula se desplaza al lado enfermo.
2. Es la causa más frecuente del síndrome de Lermièrre.
3. El tratamiento de elección es la clindamicina.
4. El dolor se hace unilateral.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El absceso periamigdalino presenta odinofagia UNILATERAL (respuesta 4 correcta). El tratamiento de elección son los corticoides y la penicilina de amplio espectro. La úvula se desplaza hacia el lado sano (empujada desde el enfermo). El síndrome de Lermièrre, producido por tromboflebitis de la vena yugular interna, aparece en los abscesos/flemones parafaríngeos.

-----O-----

Un varón de 54 años acude a urgencias refiriendo un cuadro de vértigo con sensación de giro de objetos y cortejo vegetativo, que le sucede en decúbito lateral derecho. No refiere hipoacusia, ni acúfenos, ni otra sintomatología ORL. ¿Qué exploración deberíamos realizarle?

1. Exploración ocular para ver si hay nistagmus espontáneo.
2. Romberg.
3. Maniobra de Dix Hallpike.
4. Todas las anteriores.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clínica de vértigo en decúbito lateral derecho nos hace pensar en un vértigo paroxístico posicional benigno que es la causa más frecuente de vértigo.

Para estudiar a estos pacientes, así como a todos los que presenten un cuadro vertiginoso, deberemos explorar los oídos, el nistagmus espontáneo, Romberg, revisión de pares craneales y maniobras de Dix Hallpike, como algo básico. Opción 4 correcta.

-----O-----

De los siguientes ¿cuál es más habitual que aparezca en la arteritis temporal?

1. Necrosis de lengua
2. Claudicación mandibular
3. Necrosis de la nariz
4. Aftas orales

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Opción 2 correcta: La arteritis de la temporal es una vasculitis que afecta a vasos de mediano y gran calibre. Dentro de sus síntomas locales craneofaciales, además de la cefalea, y las alteraciones oculares, puede aparecer dolor al masticar en los músculos masticadores como consecuencia de una isquemia de la vascularización de esa zona.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes signos o síntomas podría encontrar en un síndrome vertiginoso periférico?:

1. Vértigo sin nistagmo.
2. Desviación de índices.
3. Dismetría.
4. Disdiadococinesia.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En un vértigo periférico las pruebas vestibulo- espinales se dirigen hacia el lado enfermo (Romberg, Unterberger, prueba de los índices, alteración de la marcha, etc) y existe un nistagmo horizonte-rotatorio que se dirige hacia el lado sano, opción 2 correcta. La ausencia de nistagmo es muy indicativa de que es un proceso central, así como la aparición de un nistagmo que no sea horizonte- rotatorio (vertical, oblicuo o rotatorio puro). Tampoco debe aparecer déficit sensitivos, motores, de conciencia o de otros pares craneales. Las pruebas cerebelosas deben ser normales no existiendo dismetría, temblor cerebeloso, disdiadococinesia

-----O-----

Un niño de 16 meses de edad consulta por presentar, en el curso de un cuadro catarral de vías altas, fiebre, irritabilidad y llanto. Exploración física: Tª 39,6 °C, tímpano derecho hiperémico y abombado, faringe enrojecida con exudado amarillento y secreción nasal abundante. Señale la afirmación FALSA en relación con este caso:

1. La mayor incidencia de esta enfermedad se presenta entre los 6 meses y los 3 años de edad.
2. La hipertrofia adenoidea puede ser un factor predisponente.
3. La producción de betalactamasas por parte del neumococo es cada vez más frecuente.
4. La vía de propagación más frecuente es la tubárica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta trampa. En el manual de ORL dice que el Streptococcus pneumoniae es el germen más

frecuentemente implicado en la OMA (que es lo que tiene este niño) y, por otro lado, dice que “cada vez es más frecuente la producción de GÉRMENES productores de betalactamasas”. Pero NO dice que el neumococo produzca betalactamasas, eso es falso, porque la resistencia del neumococo a betalactámicos no está mediada por betalactamasas, sino porque sintetiza PBPs (proteínas de unión a penicilina) anómalas a las que no podrían unirse los betalactámicos. Por eso, la opción 3 es falsa. El resto de opciones son correctas.

-----O-----

La fonomicrocirugía endolaríngea es el tratamiento de elección de todas las siguientes patologías excepto:

1. Quiste intracordal
2. Edema de Reinke
3. Nódulos vocales
4. Pólipo de cuerda vocal

Resp. Correcta: 3

Comentario: El tratamiento de elección de los nódulos vocales es la foliaría.

-----O-----

Mujer de 40 años que refiere acúfeno del oído izquierdo sincrónico con el pulso junto con hipoacusia reciente de ese mismo oído. Por otoscopia vemos una tumoración rojiza pulsátil. Indique el diagnóstico MÁS probable:

1. Carcinoma de oído medio.
2. *Glomus* timpánico.
3. Colesteatoma.
4. Otosclerosis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El *glomus* o tumor timpánico clínicamente se manifiesta como una hipoacusia transmisiva con acúfeno pulsátil. A la exploración se observa una masa rojiza pulsátil proveniente del hipotímpano que abomba la membrana timpánica. Progresivamente puede destruir el oído interno y producir hipoacusia neurosensorial y mareo, así como también afectación del nervio facial. Si este tumor se inicia en el agujero yugular se denomina *glomus* yugular y sus primeros síntomas se relacionan con la compresión de los pares craneales bajos. El carcinoma de oído medio puede manifestarse como otalgia o pólipo en el oído medio y es mucho menos frecuente que el tumor glómico (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Acude a su consulta un paciente varón de 64 años de edad por presentar una lesión nodular laterocervical derecha de 3 meses de evolución. El paciente se encuentra asintomático y carece de antecedentes médicos relevantes salvo ser fumador de 50 paquetes/año. Mediante palpación se objetiva una adenopatía yugular derecha de 2 cm. de diámetro, indurada, no dolorosa y adherida a planos profundos. La exploración fibroscópica de la vía aerodigestiva superior es anodina. La PAAF ecoguiada es concluyente para carcinoma epidermoide. La tomografía contrastada objetiva la

metástasis descrita pero no permite ubicar la lesión primaria. Según su criterio, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir?:

1. Realizaría la adenectomía de la lesión palpable.
2. Realizaría un vaciamiento cervical funcional derecho y una amigdalectomía derecha profiláctica.
3. Iniciaría el tratamiento con radioterapia de la lesión palpable.
4. Solicitaría un PET-TAC.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La presencia de una adenopatía cervical metastásica obliga a estudiar la localización del tumor primario.

Este estudio se realiza habitualmente mediante exploración (inspección y palpación de cavidad oral, fibroscopia flexible, laringoscopia indirecta, etc) y TAC.

Si la exploración concienzuda y la imagen no muestran una potencial localización del tumor primario estamos ante una metástasis de primario desconocido.

Suele realizarse un PET-TAC para localizar las áreas de alta actividad metabólica y así tomar biopsias de la región captante. Si no se dispone de la técnica o no es orientativa puede realizarse un mapa biopsico de la vía aerodigestiva superior.

Si se identifica la lesión, se tratará según su estadiaje TNM.

Si no se identifica, suele realizarse un vaciamiento cervical funcional + RT + QT.

-----O-----

Paciente mujer de 65 años de edad con antecedentes sin interés que acude a consulta por rinorrea sanguinolenta en fosa nasal izquierda de 2 meses de evolución, además de dolor facial que en la última semana es más intenso. Se ha notado una tumoración laterocervical izquierda que no le molesta. Se le realiza una exploración ORL observando una adenopatía laterocervical izquierda mayor de 2 cm y en la fibroendoscopia se aprecia una tumoración que se ve por meato medio izquierdo, con restos hemáticos y se toma biopsia. Se solicita PAAF de la adenopatía y se solicita TC cráneo-cervical. Resultados de tumoración de fosa nasal AP: tumoración maligna. PAAF: metástasis de tumoración maligna. TC: tumoración de seno maxilar que erosiona paredes y sale hacia fosa nasal izquierda. ¿Qué extirpe anatomopatológica será la más frecuente y qué tratamiento indicaríamos?

1. Será un linfoma y el tratamiento será Radio-quimioterapia.
2. Será un carcinoma y el tratamiento será con Radio-quimioterapia.
3. Será un linfoma y el tratamiento será quirúrgico.
4. Será un carcinoma y el tratamiento será quirúrgico con o sin Radio/Quimioterapia postcirugía.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los carcinomas de senos paranasales y fosas nasales se tratan con cirugía, si se pueden reseca y se complementa con radio-quimioterapia postcirugía si se precisa, en función del estadio en el que se encuentren.

La cirugía puede ser desde una técnica endoscópica para los tumores pequeños hasta una intervención con abordaje externo o una combinación de ambas técnicas, dependiendo de la localización y extensión de la tumoración.

-----O-----

El seno más frecuentemente afectado en la sinusitis del adulto es:

1. Seno frontal.
2. Seno etmoidal.
3. Seno esfenoidal.
4. Seno maxilar.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El seno que se afecta con más frecuencia en las sinusitis del adulto es el seno maxilar (Opcion 4 correcta). En los niños es el seno etmoidal.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes es el principal factor pronóstico de los tumores ORL?

1. Ganglios cervicales afectados (N+)
2. Tamaño tumoral
3. Metástasis
4. Edad y comorbilidades del paciente

Resp. Correcta: 1

Comentario: En todos los tumores ORL, el principal factor pronóstico es la existencia de ganglios afectados (N+). Las metástasis a distancia se producen sobre todo a nivel pulmonar. (Opción 1 correcta)

-----O-----

Acude una madre, muy preocupada, porque su hijo de 3 años no oye bien desde hace varios meses. Lo más probable es que se trate de:

1. Una hipoacusia mixta bilateral
2. Una hipoacusia neurosensorial bilateral
3. Una hipoacusia de transmisión bilateral
4. Una hipoacusia retrococlear bilateral:

Resp. Correcta: 3

Comentario:

1. La causa más frecuente de hipoacusia en la infancia es, con mucha diferencia, la otitis serosa bilateral. Es, por tanto, lo primero en lo que tenemos que pensar ante un niño con sordera. Como consecuencia del acúmulo de moco en oído medio, da lugar a una hipoacusia de transmisión bilateral.

A un paciente de 18 años que ha presentado una parálisis facial de Bell derecha, le realizamos un timpanograma con reflejos estapediales de ambos oídos y nos salen unas curvas tipo A de Jerger sin reflejos en el oído derecho. Eso es debido a:

1. El paciente tiene una otitis media crónica secretora de oído derecho.
2. Parálisis del músculo del estribo.
3. La parálisis de la musculatura de la cara impide que salga el reflejo.
4. La parálisis de Bell se asocia con una otitis media aguda.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Cuando hay una afectación del nervio facial pueden verse afectadas distintas ramas según la zona del nervio afectada. Si no se consiguen unos reflejos estapediales con unas curvas normales de timpanograma, nos está indicando una afectación de la rama que inerva el músculo del estribo.

La parálisis facial no se asocia con una otitis media aguda.

Con las curvas tipo A descartamos una otitis media crónica secretora.

Varón de 32 años que acude al Servicio de Urgencias aquejado de odinofagia de dos días de evolución, con fiebre termometrada de hasta 39 °C. A la exploración presenta unas amígdalas hipertróficas, de aspecto hiperémico y con un exudado pultáceo bilateral. No hay abombamientos de los pilares anteriores. El paciente es alérgico a betalactámicos. Señale el antibiótico MÁS correcto en este caso:

1. Gentamicina.
2. Amoxicilina-Clavulánico.
3. Claritromicina.
4. Cloxacilina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las amígdalas pultáceas (placas blanquecinas en el interior de las criptas amigdalinas) junto con fiebre, indican una amigdalitis aguda. El tratamiento de elección en estos casos son los betalactámicos; sin embargo, dado que el paciente es ALÉRGICO, la alternativa son los macrólidos como la claritromicina (respuesta 3 correcta).

Paciente de 57 años, no fumador, que acude por adenopatía de 2 meses de evolución. En la exploración general no presenta otras adenopatías, y en el área ORL no tiene ninguna lesión. ¿Cuál sería el orden de las pruebas diagnósticas que debería pedir a continuación?

1. Biopsia incisional de la adenopatía, TAC cervical y si son negativas, PET-TAC.

2. Biopsia excisional de la adenopatía, TAC cervical y si son negativas, PET-TAC.
3. ECO-PAAF y si sale epidermoide biopsia de la adenopatía y TAC cervical.
4. ECO-PAAF y si sale epidermoide y el TAC cervical es negativo, pedir PET-TAC.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Opción 4 correcta: Ante una adenopatía cervical sin lesión primaria:

1º ECOPAAF y TAC cervical

Si el resultado es de linfoma: biopsia.

Si el resultado es de carcinoma epidermoide y seguimos sin localizar lesión primaria en área ORL: PET-TAC.

-----O-----

En relación con la otitis media secretoria unilateral del adulto, señalar la afirmación INCORRECTA de las que se relacionan a continuación:

1. El Weber audiométrico se desplaza al oído enfermo.
2. El tratamiento de elección consiste en la colocación de un drenaje transtimpánico en el oído afectado.
3. En ocasiones, la otitis media secretoria del adulto puede ser expresión de un cáncer de Cavum.
4. La impedanciometría es una prueba diagnóstica definitiva.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Muy importante: Lo primero a descartar ante una otitis media secretoria unilateral del adulto es un carcinoma de cávum. El tratamiento habitual de una otitis secretoria unilateral consiste en vasoconstrictores y antiinflamatorios a los que se añade tratamiento antibiótico y si existe hipertrofia adenoidea importante, se realiza adenoidectomía. La inserción de drenaje transtimpánico está indicada en niños con otitis medias agudas recurrentes, por lo que la pregunta al tratar de un adulto nos da la respuesta incorrecta. Opción 2 correcta.

-----O-----

Mujer de 60 años que hace unos años que no oye bien. Nos explica que su madre, abuela, y hermana, ya fallecidas, también tuvieron problemas de audición. Refiere que los problemas comenzaron hacia los 25 años y la cosa fue empeorando con los años y sobre todo con sus dos embarazos. Con respecto a las hipoacusias, ¿qué relación de las siguientes es FALSA?

1. Hipoacusia brusca: duración 30 dB, 3 frecuencias consecutivas.
2. Trauma acústico: escotoma en 4.000 Hz.
3. Ménière: al principio fluctuante y peor en agudos.
4. Neurinoma: peor en agudos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico cuyo enunciado es totalmente prescindible, recuerda siempre leer primero la última frase. Recuerda que el Ménière es la excepción a la regla "los accidentes de conducción (conducción = transmisión) son graves", siendo una hipoacusia neurosensorial que es peor en graves, cuando normalmente las NS son peores en agudos (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Paciente de 35 años que acude a Urgencias por parálisis facial derecha de 24 horas de evolución. Como antecedente de interés refiere una cirugía otológica del lado derecho hace dos días por un colesteatoma. El paciente insiste en que en el postoperatorio inmediato no presentaba la parálisis facial y que esta apareció al día siguiente de la cirugía. En la exploración de aprecia una parálisis facial derecha con imposibilidad para el cierre ocular y desviación de la comisura bucal al lado izquierdo. La herida quirúrgica presenta buen aspecto. A este respecto, señale la afirmación CORRECTA:

1. Se trata de una parálisis facial central.
2. Se trata de una parálisis facial periférica diferida, que presenta un mejor pronóstico.
3. El tratamiento se basa en el uso de gotas antibióticas
4. Con toda seguridad, el nervio facial ha sido interrumpido durante la cirugía.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico sobre una parálisis facial periférica (afectación del tercio superior y antecedente otológico). El hecho de que el paciente no presentase la parálisis facial justo después de la cirugía sino que esta apareciese a las 24 horas de la misma, habla a favor de una parálisis facial diferida. Las parálisis faciales diferidas tienen mejor pronóstico que las inmediatas y se producen principalmente por inflamación del nervio facial (por la manipulación durante la cirugía) (respuesta 2 correcta), no por interrupción del nervio (el paciente en este caso presentaría una parálisis facial inmediata). El tratamiento se basa en el uso de corticoides sistémicos.

-----O-----